

9 - 03- Le Cancer de la Langue - Pr. ROCHDI

(0:02 - 0:26)

Toujours dans le module de la pathologie ORL, avec le dernier chapitre sur le cancer de la langue. Le cancer de la langue fait partie du cancer de la cavité buccale et de l'europarax. C'est un cancer qui reste commun et fréquent puisqu'il constitue 20% des cancers de voie aérodynamique supérieure.

(0:27 - 0:44)

Sur le plan nosologique, on le sépare en deux parties. Le cancer de la langue mobile et le cancer de la base de langue. Pourquoi on fait cette séparation ? Parce qu'il y a une différence sur le plan clinique et sur le plan thérapeutique.

(0:46 - 1:11)

Le cancer de la langue touche un organe qui est très important et qui a un rôle sur le plan physiologique dans l'élocution, dans la mastication, dans l'égglutition. Le traitement consistera en une chirurgie, soit une radiochimie-thérapie, ou bien les deux. Mais malgré ces moyens thérapeutiques, le pronostic reste mauvais.

(1:16 - 1:49)

Alors d'abord, on va faire un rappel anatomique de la langue, qui est un organe qui constitue essentiellement de muscles, puisqu'il comporte 17 muscles. On en distingue deux parties, une partie antérieure qui constitue du tiers antérieur de ce qu'on appelle la langue mobile, séparée par le V lingual en arrière de la base de langue. Le V lingual est constitué de papilles gustatives, donc la base de langue fait partie de l'oropharynx, mais la langue mobile fait partie de la cavité buccale.

(1:50 - 2:31)

Cette langue mobile est constituée de deux bords marginaux, qui sont reliés en avant par une pointe, et qui comportent deux faces, une face dorsale et une face ventrale, et qui sont tapissées par une unité. Le drainage lymphatique de la langue se fait au niveau des gonduliens sous-mentonniers, sous-maquillaires, éjugulocales ou bien supérieures, moyennes et inférieures. Le drainage lymphatique est homolatéral, mais il est croisé et bilatéral au niveau de la pointe et au niveau de la ligne médiane.

(3:23 - 4:07)

Comme on l'a dit, le drainage lymphatique se fait au niveau des gonduliers, sous-mentonniers, sous-maquillaires, sous les gondes 1, 2, 3, 4, c'est la chaîne jugulocale quotidienne. Alors on va

commencer d'abord par l'étude du concept de la langue mobile. Ce concept constitue 30% du carcinome de la cavité buccale.

En France, on estime jusqu'à 2 000 nouveaux cas par an. L'âge du survenu, en moyenne, c'est vers 55-60 ans. Les âges extrêmes, c'est entre 30 et 70 ans, avec une prédominance toujours masculine.

(4:08 - 5:41)

Alors quels sont les facteurs de risque du cancer de la langue? D'abord, en premier, le facteur commun de presque tous les cancers des voies aérologiques supérieures, c'est le tabac. Le tabac avec ses héritants de la muqueuse respiratoire vont entraîner des modifications cytologiques qui vont être responsables de la transformation manique. Deuxième facteur, c'est le tabac.

C'est un cofacteur qui agit avec le tabac et qui est responsable du cancer de la cavité buccale. Troisième élément, c'est le mauvais état du codentère, c'est-à-dire les caries dentaires avec l'apparition des chicots dentaires qui vont hériter, bien sûr, c'est aussi si on a une prothèse qui est mal adaptée, qui vont hériter le bord marginal de la langue. Quatrième facteur, c'est les facteurs viraux.

Le human papillomavirus, l'HPV, est responsable en partie, mais de façon moins importante qu'au niveau de la base de langue, de l'apparition et du cancer de la langue puisqu'on estime que 14% des tumeurs de la langue mobile contiennent des stigmates d'infection virale. Alors, quelles sont les lésions précancéreuses ? D'abord, les dysplasies. Les dysplasies qu'on peut voir, c'est-à-dire différents types de lésions, peuvent aller d'une dysplasie légère jusqu'à une dysplasie sévère que certains auteurs considèrent comme un carcinome in situ.

(5:42 - 6:20)

Première lésion précancéreuse, c'est l'érythroplasie, qu'on voit sur la photo. L'érythroplasie constitue une lésion rouge avec des bords irréguliers, mais dans ce genre de lésion, il n'y a pas d'infiltration, elle reste souple à la palpation, mais il y a un risque de 30% de cancérisation. La leucoplasie, ce sont des plaques blanchâtres à bords irréguliers, et bien sûr, elle reste souple, mais elle comporte un risque de transformation maligne qui peut atteindre 9%.

(6:20 - 7:54)

Troisième lésion, c'est le léquin blanc, qui constitue des nappes blanchâtres et qui comporte un risque de transformation maligne de 10% des cas. La papillomatose orale, qui est en rapport avec une infection virale dans certains types de l'HPV, en sont responsables, et dans sa forme floride, constitue un risque de transformation maligne qui peut atteindre jusqu'à 30% des cas. On incrimine aussi certains types de dénutrition qui sont responsables du mycovitaminose chronique

de la vitamine A et de la vitamine C. Sur le plan anatomologique, trois formes macroscopiques peuvent être observées.

Il y a la forme ulcérée, la forme bourgeonnante et la forme infiltrante. Mais la forme la plus fréquente, c'est la forme ulcéro-bourgeonnante, comme on voit sur la photo ici, avec une ossuration centrale, entourée par des bords irréguliers et surtout surélevés, et lorsqu'on palpe ses lésions, ce ne sont pas des lésions qui sont souples, ils sont endurés, sur le bord et au centre, avec même une enduration qui peut s'étendre à travers la langue. Sur le plan histologique, le type histologique le plus fréquent, c'est le carcinome épidermoïde, qui est en rapport avec le tabac, compacteur d'ondes, ainsi que la sucrée, comme on peut avoir d'autres types, mais de façon moins fréquente, beaucoup plus rare, les sarcomes, les lymphomes, parfois, des animaux carcinomes.

(7:56 - 9:32)

L'extension peut se faire soit en avant vers la pointe de la langue, soit en arrière vers la base de langue, comme elle peut se faire vers le plancher du cadre. Parfois, on peut avoir une extension latérale vers la région amygdale, pilier antérieur, pilier postérieur, comme on peut avoir une extension à travers la base de langue vers le larynx. Ça concerne l'extension locale.

L'extension longue bionnaire, les cancers de la langue sont des cancers qui sont lymphophiles. Donc, ils vont concerner le groupe 1, le groupe 2, le groupe 3 et le groupe 4. L'atteinte peut être bilatérale, comme on l'a dit. Si on a une atteinte qui touche la pointe de langue, on verra ce que la tumeur arrive au niveau de la ligne médiane.

Les métastases à distance concernent surtout les poumons. Alors, sur le point de diagnostic, quels sont les signes d'appel d'un cancer de la langue? D'abord, il y a la gêne à la mastication, avec une sensation de corps étranger, picotement aux mouvelures, au contact, comme on peut avoir parfois des crachats sanguinolents. Parfois, le patient peut manifester, la lésion peut être complètement asymptomatique.

Uniquement, le patient peut consulter pour des autalgies réflexes. Donc, devant des autalgies, où l'examen ontologique est tout à fait normal, pensez à une lésion au niveau de la cavité buccale, en l'occurrence au niveau d'avant. Comme, bien sûr, lorsque le patient se présente, on a une hépatite cervicale.

(9:35 - 10:21)

Alors, l'examen clinique, d'abord l'inspection, demander au patient d'ouvrir la bouche, de tirer la langue, prendre les abaisse-langues, mettre les gants, et d'abord inspecter pour voir le siège de la lésion. Est-ce qu'il est au niveau des bords marginaux? Est-ce qu'il est au niveau de la pointe? Est-ce qu'il est au niveau de la face ventrale? Appréciez sa taille. Et bien sûr, demandez au patient de faire la protraction de la langue.

Vérifiez est-ce que cette protraction est toujours possible. Parce que lorsque, en présence d'une telle lésion, et que le patient n'arrive pas à protraquer sa langue, ça veut dire que l'atteinte arrive au niveau de la base de langue. Et c'est un très mauvais signe qui oriente vers une forme évoluée.

(10:21 - 10:50)

La palpation, on va apprécier l'infiltration, c'est-à-dire vérifier est-ce que l'atteinte arrive au niveau de la ligne médiane. Est-ce que l'examen se fait vers le plancher du casque? Est-ce qu'il est une atteinte de la base de langue? On a l'impression, la base d'implantation. Bien sûr, la lésion, comme on l'a dit, se manifeste souvent sous forme d'une lésion ulcéroborjonante qui est endurée au centre et sur la périphérie et en profondeur avec des bords qui sont surélevés.

(10:50 - 11:18)

Ça, c'est un signe qui est très important, parce que certains types de lésions qui vont faire le diagnostic différentiel se manifestent par des bords irréguliers, mais sans surélévation des bords. Ça, c'est un des cas de patients. Par exemple, dans ce cas-là, on remarque une lésion au niveau des bords marginal gauche où on voit une lésion ulcéroborjonante avec un centre électrotique ici et on remarque ici les bords qui sont surélevés.

(11:18 - 11:54)

Même chose ici, mais de façon moins importante. Là, c'est une forme ulcérée et infiltrante, une forme ulcéroinfiltrante et la palpation au doigt est très importante ici. Deuxième partie de l'examen clinique, c'est l'examen des herbes ganglionnaires et essayer d'apprécier est-ce que le patient présente des ganglions, préciser leur nombre, leur caractère, est-ce qu'ils sont endurés, est-ce qu'ils sont infiltrants, est-ce qu'il y a une extension au niveau de la peau, est-ce que l'atteinte est unilatérale ou bilatérale.

(11:54 - 12:42)

On complétera par l'examen ORL pour rechercher d'autres lésions associées, c'est-à-dire rechercher un cancer synchrone en examinant le reste de la cavité buccale, l'oropharynx, à l'aide d'un miroir l'arranger en appréciant à la muqueuse du lipopharynx et du larynx, ainsi qu'un examen des fosses nasales et du cavom. L'examen général recherche des signes d'appels pulmonaires, osseuses ou abdominaux qui orienteront vers des métastases à distance. En même temps, on essaye d'apprécier les pas généraux du patient en recherchant des comorbidités, des signes d'atteintes rénales respiratoires, cardiaques, qui vont être pris en considération dans l'indication thérapeutique.

(12:45 - 13:12)

Concernant le diagnostic différentiel de ce type de lésions de la langue mobile, il y a d'abord les ulcérations traumatiques. Normalement, les ulcérations traumatiques, comme on l'a dit, les bords ne sont pas surélevés et d'ailleurs, ils doivent disparaître après traitement et après suppression du facteur irritant. En général, après 8 jours, 10 jours, ils doivent disparaître, mais s'il y a peu de distance, il faut faire une biopsie à l'aide d'un acteur.

(13:13 - 13:49)

Deuxième diagnostic différentiel, c'est les autres tumeurs bénis, un type de fibrose, des tumeurs conjonctives, des tumeurs bilambres ou des papillomes, mais c'est l'anapathie qui permettra de trancher. Les granulomatoses peuvent se manifester, ça fait des infections spécifiques, une tumeur pélose, on l'a dit plus vite, peuvent se manifester sous forme d'ulcérations, mais ça veut dire des ulcérations qui sont souples à notre patient, qui ne saignent pas facilement et bien sûr associées en général à des autres localisations pulmonaires. Et bien sûr, l'examen bactériologique permettra de rectifier le diagnostic.

(13:51 - 15:35)

En conclusion, un type clinique devant toute lésion ulcérée de la langue, qui dure plus de 15 jours malgré la suppression du facteur irritant, malgré le traitement, et doit considérer comme une lésion suspecte et fera l'objet d'une biopsie avec étude histopathologique. Alors une fois le diagnostic confirmé, première étape, ce qu'il faudra faire, c'est de faire une palendoscopie, c'est-à-dire rechercher une seconde localisation au niveau des voies aérodigestives supérieures et inférieures, bien sûr. Donc c'est un geste qui se fait sur l'intérieur général.

On fera une oesopargoscopie, une bronchoscopie, ainsi qu'une rhinocavoscopie pour rechercher une tumeur synchrone, puisqu'ils entendent qu'on a le tabac et l'HPV, surtout le tabac et l'alcool comme facteurs de risque. Premier examen à demander concernant l'imagerie, c'est l'IRM. L'IRM, on est au niveau des parties moindres.

Au niveau de la langue, il n'y a pas d'os, donc l'IRM permettra d'apprécier parfaitement l'extension au niveau de la langue, au niveau de la base de langue, ainsi qu'au niveau des planchers buccaux. Lorsqu'on va suspecter une atteinte osseuse, dans ce cas-là, on demandera un scanner de la cavité buccale pour rechercher des signes d'atteinte osseuse. Le bilan paraclinique général va être centré d'abord sur le bilan d'extension, un scanner thoracique ou bien un radio-thoracique pour rechercher des signes d'atteinte pulmonaire.

(15:35 - 16:07)

Une infographie hépatique et abdominale pour rechercher des lésions secondaires abdominales. Et bien sûr, rechercher une pathologie associée aux ORL et atteinte cardiaque hépatique-ORL. Une consultation en stomatologie pour rechercher un foyer infectieux dentaire, des caries dentaires à traiter avant de démarrer une éventuelle radiothérapie, et dans ce cas-là, une

panoramique dentaire est souvent demandée.

(16:08 - 16:33)

Le bilan biologique préopératoire, bien sûr, permettra de rechercher des anomalies à corriger avant l'étape thérapeutique. Une fois le bilan clinique et cardiaque réalisé, on pourra classer le malade selon la classification TNM. Après la modification réalisée en 2017, la classification est basée sur deux paramètres très importants.

(16:33 - 16:57)

D'abord, c'est la taille de la tumeur. Et deuxième chose, c'est le degré d'invasion en profondeur. Lorsque la tumeur est inférieure à 2 cm, ou bien entre 2 et 4 cm, ou bien s'il dépasse 4 cm, ou bien s'il y a une extension locale, régionale, telles atteintes mandibulaires, atteintes de la face, et les espaces profonds de la face.

(16:57 - 17:13)

Le degré d'invasion aussi est un paramètre à prendre en considération. Après la classification de la tumeur, il y a la classification de métastase lymphonodulaire. Il y a la classification clinique et anatomopathologique de N1.

(17:13 - 17:47)

Lorsqu'on a une atteinte lymphonodulaire unique au multiple lymphonodulaire homolatérale, et qui est inférieure à 6 cm. Lorsque l'atteinte est contralatérale et bilatérale toujours inférieure à 6, on est dans le stade 2. Lorsqu'elle dépasse 6 cm, on est dans le stade 3. L'atteinte pathologique, la classification pathologique, lorsqu'on a plus de 5 ganglions, à partir de 5 ganglions atteints, on parle de N2. Sinon, c'est un N1.

(17:49 - 18:20)

Et bien sûr, lorsqu'on est en présence de métastase à distance, le patient est classé N+. Alors, qu'en est-il du traitement des cancers de la langue mobile ? Les moyens dont on dispose, c'est la chirurgie, qui peut se faire sur la tumeur et sur les ganglions, puisque le cancer de la langue, c'est un cancer qui est lymphophile. On dispose aussi de la radiothérapie, sous forme de radiothérapie externe ou de la brachythérapie, qui est de moins en moins utilisée.

(18:20 - 18:48)

Et de la chimiothérapie. Alors, la chirurgie doit obéir aux règles classiques de la chirurgie oncologique, c'est-à-dire réaliser au mieux une XRS. Quand on fait de la chimiothérapie avec des marges de sécurité qui doivent être assez importantes, dans ce cas-là, on peut réaliser soit une mysolectomie, jusqu'à une mysolectomie transversale comportant tout un ordre mobile.

(18:48 - 19:39)

Et dans ce cas-là, on sera obligé de reconstruire, en général, soit par des lombos régionaux qui sont vascularisés, ou bien par des lombos libres. Le chiral ganglionnaire emportera tout le tissu circulaire infatigué cervical, soit de façon unilatérale, sinon il doit être bilatéral lorsque l'atteinte, je le rappelle, lorsque l'atteinte tumorale touche la pointe de langue, ou bien atteint la ligne médiane. L'indication de la radiothérapie, de la radiochimiothérapie, d'emblée en post-opératoire, tout ça, la prise de décision se fait en général dans le cadre de staff multidisciplinaire en associant ORL, oncologue, radiothérapeute et radiologue.

(19:44 - 20:14)

Deuxième partie de cette question du cancer de la langue, c'est le cancer de la base de langue. On a dit qu'elle appartient au cancer de l'oropharynx. Les facteurs de risque sont les mêmes, c'est le tabac, l'alcool, mais là, le rôle de l'HPV, c'est que le sérotype 16, est beaucoup plus important et touche surtout le sujet gène.

(20:16 - 21:19)

La situation profonde de la base de langue fait qu'en général, les diagnostics sont tardifs. Ce sont des tumeurs onguées qui sont infiltrantes, plus ou moins radioresistantes, surtout dans les HPV négatifs, mais ils sont très lymphophiles, beaucoup plus lymphophiles que les tumeurs de la langue médiane. La clinique, alors sur le plan clinique, c'est des lésions qui sont bourgeonnantes, soit ulcérées, soit infiltrantes, qui vont se manifester par une induration de la base de l'ulcération, un saignement au contact, et l'examen clinique doit apprécier toujours par examen à la base de langue, aidé au mieux par une nasophibroscope, d'apprécier aussi à la fois le patient, l'extension, et l'examen local, complété comme le cancer de langue mobile par l'examen des organes glionnaires cervicales, et l'examen général en cherchant des signes de métastase, et apprécier l'état génétique.

(21:21 - 22:10)

Le traitement, on a en général la chirurgie ou bien la radiochimie thérapie, mais il faut savoir que l'indication de la chirurgie dans les cancers de la base de langue reste limitée aux très petits tumeurs, puisque c'est un organe qui est profond, et la chirurgie de la base de langue a un authentissement fonctionnel très important, donc on optera beaucoup plus pour, dans les formes un peu avancées, voire plus avancées, on optera beaucoup plus pour une radiochimie thérapie, surtout chez les patients qui sont HEV positifs, et c'est eux qui répondent beaucoup plus à la radiochimie thérapie, et qui ont de meilleurs résultats, tout en sachant que le pronostic, il reste quand même mauvais dans ce genre de tumeurs.